Dr. Felipe de Bulhões
UROLOGISTA & CIRURGIÃO GERAL

MICROCIRURGIA & PLANEJAMENTO

SAÚDE REPRODUTIVA MASCULINA

Fertilidade Masculina, Varicocele com Microscópio & Vasectomia Sem Bisturi

O guia completo para as duas fases do planejamento reprodutivo do homem: como restaurar o potencial fértil com microcirurgia ou realizar a Vasectomia Sem Bisturi com recuperação rápida.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NESTE GUIA CLÍNICO:

- Por que o fator masculino responde por 50% das dificuldades de engravidar — e o papel oculto da Fragmentação do DNA Espermático;
- Varicocelectomia Microcirúrgica Subinguinal com Microscópio Óptico: por que é o padrão-ouro mundial (EAU/AUA);
- Como proteger ou recuperar a produção de espermatozoides em homens que usaram testosterona;
- Vasectomia Sem Bisturi (No-Scalpel): como funciona a técnica em 30 minutos, recuperação em 48–72h e regras da Lei atual.

Dr. Felipe de Bulhões Ojeda
Médico Urologista & Cirurgião Geral · CRM-SP 202291 | RQE 146538 | RQE 114019
Formação em Urologia pelo Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR — São Paulo)
TCBC · SBU · AUA · EAU
SÃO PAULO & CAMPINAS

Olá! Sou o Dr. Felipe de Bulhões, médico Urologista (IDOR) e Cirurgião Geral (TCBC).

Na saúde reprodutiva masculina, atuo nos dois momentos mais importantes da vida familiar de um homem: quando o casal busca realizar o sonho de ter filhos — exigindo investigação andrológica refinada e microcirurgia de alta precisão — e quando a família já está completa, oferecendo a **Vasectomia Sem Bisturi** com máximo conforto e segurança. Este guia reúne as informações essenciais para sua decisão.

1. Fertilidade Masculina e Varicocele: Muito Além do Espermograma Básico

Em cerca de **50% dos casais** que enfrentam dificuldade para engravidar (ou perdas gestacionais de repetição), existe um fator masculino associado. A **Varicocele** — dilatação das veias do plexo pampiniforme que drenam o testículo — é a causa tratável mais comum de infertilidade masculina (presente em até 40% dos casos primários e 80% da infertilidade secundária).

O refluxo venoso eleva a temperatura intratesticular e gera **estresse oxidativo**, danificando não apenas a contagem e a motilidade, mas também a integridade genética do espermatozoide (**Fragmentação do DNA Espermático**) e a produção testicular de testosterona pelas células de Leydig.

TÉCNICA CIRÚRGICA	VARICOCELECTOMIA MICROCIRÚRGICA (PADRÃO-OURO)	TÉCNICAS CONVENCIONAIS SEM MICROSCÓPIO
Magnificação Óptica	Uso de **Microscópio Cirúrgico (10x a 25x)** por acesso subinguinal (sem abrir aponeurose muscular).	Olho nu ou lupa simples, dificultando a distinção de microvasos aderidos.
Segurança Arterial & Linfática	Preservação milimétrica da **artéria testicular** e dos vasos linfáticos; risco de hidrocele **< 1%**.	Maior risco de lesão arterial ou obstrução linfática (hidrocele pós-operatória em 5–10%).
Taxa de Sucesso	Menor índice de recidiva (<1–2%), melhora seminal em **60% a 80%** dos pacientes e aumento de gravidez espontânea ou sucesso na FIV.	Taxa de persistência/recidiva venosa significativamente superior (até 10–15%).

2. Reposição de Testosterona e Fertilidade: É Possível Reverter?

O EFEITO CONTRACEPTIVO DA TESTOSTERONA EXÓGENA

Muitos homens jovens utilizam testosterona ou anabolizantes sem saber que o hormônio externo inibe os sinais da hipófise (LH e FSH), fazendo o testículo parar de produzir espermatozoides. Se você deseja ter filhos, **nunca inicie testosterona convencional sem orientação urológica** — dispomos de protocolos específicos (moduladores seletivos e gonadotrofinas como hCG/FSH) que estimulam a testosterona endógena preservando ou resgatando a espermatogênese.

3. Vasectomia Sem Bisturi (No-Scalpel Vasectomy): Contracepção Definitiva

Para o homem ou casal que já definiu seu planejamento familiar e deseja encerrar o uso de anticoncepcionais hormonais femininos ou DIU, a **Vasectomia Sem Bisturi** é o método contraceptivo mais seguro e eficaz da medicina (eficácia **> 99,8%** após confirmação pelo espermograma).

Como Funciona a Técnica Sem Bisturi

- Em vez de cortes com lâmina de bisturi, utiliza-se uma pinça hemostática de ponta fina para afastar delicadamente as fibras da pele escrotal por micropunção (~3 a 5 mm);
- Realizada com anestesia local (ou sedação leve opcional) em cerca de **25 a 30 minutos**;
- Mínimo sangramento, muitas vezes sem necessidade de pontos externos, e retorno às atividades leves em **48 a 72 horas**.

O Que NÃO Muda Após a Vasectomia

- **Produção de Testosterona e Libido:** 100% preservadas (os hormônios saem pela corrente sanguínea, não pelo canal deferente);
- **Potência e Sensibilidade:** Nenhuma alteração nos nervos ou vasos da ereção;
- **Volume do Sêmen:** 95% do líquido ejaculado vem da próstata e das vesículas seminais — o aspecto visual da ejaculação permanece idêntico.

Legislação Atualizada (Lei nº 14.443/2022): A vasectomia pode ser realizada por qualquer homem com capacidade civil plena a partir de **21 anos de idade** (ou com pelo menos 2 filhos vivos), respeitado o prazo legal de manifestação de vontade, **sem necessidade de assinatura ou consentimento do cônjuge**.

Checklist de Planejamento Reprodutivo: Qual é o Seu Momento?

AUTOAVALIAÇÃO CLÍNICA

- ☐ Casal tentando engravidar há 6–12 meses sem sucesso ou com histórico de abortamento;
- ☐ Dor testicular tipo peso/latejamento que piora ao ficar em pé ou após atividade física;
- ☐ Já tem a família completa e busca a Vasectomia Sem Bisturi com rápida recuperação;
- ☐ Diagnóstico de Varicocele no exame físico/ultrassom ou alteração no espermograma;
- ☐ Fez ou faz uso de testosterona/ergogênicos e deseja preservar ou recuperar a fertilidade;
- ☐ Deseja realizar Reversão Microcirúrgica de Vasectomia prévia (Vasovasostomia).

Orientação Médica: Tanto a investigação de fertilidade/varicocele quanto o planejamento da Vasectomia Sem Bisturi começam em uma consulta urológica estruturada e acolhedora.

4. Segurança no Pós-Procedimento e Acompanhamento

PROCEDIMENTO	PROTOCOLO DE RECUPERAÇÃO E CONTROLE
Vasectomia Sem Bisturi	Alta no mesmo dia; repouso relativo por 48–72h e retorno às relações em 7 dias. **Fundamental:** manter método contraceptivo até a realização do **Espermograma Pós-Vasectomia (após 60–90 dias e ~20 ejaculações)** confirmando azoospermia (zero espermatozoides).
Varicocelectomia Microcirúrgica	Procedimento Hospital Day (alta no mesmo dia); retorno ao trabalho de escritório em 3 a 5 dias e treinos em 2 a 3 semanas. O ciclo da espermatogênese dura ~74 dias, com reavaliação seminal aos **3 e 6 meses**.

Unidades de Atendimento & Teleconsulta

São Paulo — Clinovi Paulista
Av. Paulista, 1048, 18º andar — Bela Vista, São Paulo - SP

São Paulo — Clinovi Pinheiros
Av. Rebouças, 2636 — Pinheiros, São Paulo - SP

Campinas — Campinas Day Hospital
Av. Benjamin Constant, 1991 — Cambuí, Campinas - SP

Campinas — CEMED Rede D'Or São Luiz
Av. Andrade Neves, 863 — Centro, Campinas - SP · + Teleconsulta

Próximo Passo: Avaliação Médica Individualizada

Deseja discutir seu caso com sigilo absoluto, precisão diagnóstica e plano terapêutico sob medida? Nossa equipe de atendimento está pronta para orientar seu agendamento presencial ou por teleconsulta.

Falar no WhatsApp: (11) 98112-4455 | Agendar pelo Site Oficial

Atendimento Particular, Reembolso Assistido e Hospitais de Excelência · Sigilo Médico Absoluto

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS & CONFORMIDADE ÉTICA (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.336/2023)

1. Salonia A, Bettocchi C, Boeri L, et al. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health — Male Infertility & Varicocele. European Association of Urology, 2025/2026.
2. Schlegel PN, Sigman M, Collura B, et al. Diagnosis and Treatment of Infertility in Men: AUA/ASRM Guideline. J Urol. 2021.
3. Sharlip ID, Belker AM, Honig S, et al. Vasectomy: AUA Guideline. American Urological Association.
4. Conselho Federal de Medicina (CFM). Resolução CFM nº 2.336/2023. Dr. Felipe de Bulhões Ojeda — CRM-SP 202291 | RQE 146538 | RQE 114019.